TOME 17 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Rhumatologie

Collège Français des Enseignants en Rhumatologie (COFER) • 253 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 17 : Rhumatologie.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 253 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège Français des Enseignants en Rhumatologie (COFER).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	253 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 17

Collège Français des Enseignants en Rhumatologie (COFER) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 17 • Rhumatologie (253 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

- Chapitre 01 : Douleur, épanchement articulaire, Arthrite (200)
- Chapitre 02 : Rachialgie (94)
- Chapitre 03 : Arthrose (129)
- Chapitre 04 : Ostéopathies fragilisantes (128)
- Chapitre 05 : SDRC : algodystrophie (199)
- Chapitre 06 : Polyarthrite rhumatoïde (196)
- Chapitre 07 : Spondylarthrite (197)
- Chapitre 08 : Arthropathie microcristalline (198)
- Chapitre 09 : Infections ostéo-articulaires (156)
- Chapitre 10 : Tumeurs des os (307)
- Chapitre 11 : Rhumatologie transversale
- Chapitre 01 — Douleur, épanchement articulaire, Arthrite (200)
- Démarche diagnostique
- Épanchement articulaire
- Image (collège : épanchement articulaire du genou)
- Arthrite
- Douleur mécanique vs Douleur inflammatoire
- Ponction articulaire
- Image
- Analyse et interprétation du liquide articulaire après ponction
- Procédure
- Exige une préparation cutanée antiseptique, la position du malade, le choix du matériel et le choix de la voie de ponction sont fonction de l'expérience de l'intervenant et de la localisation de l'épanchement
- Rang C : la voie supérolatérale est la plus utilisée pour ponctionner le genou, patient en décubitus dorsal, genou droit tendu, quadriceps détendu. Le point de ponction se situe 1 cm au-dessus et 1 cm en dehors du coin supérolatéral de la patella. Après avoir légèrement subluxé la patella, l'aiguille doit être dirigée sous la patella, dans le sillon intercondylopatellaire.
- Image d’une ponction articulaire du genou sur le collège
- Orientation étiologique
- Démarche diagnostique devant une atteinte mono-articulaire
- Démarche diagnostique

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Douleur, épanchement articulaire, Arthrite (200)
Chapitre 02 : Rachialgie (94)
Chapitre 03 : Arthrose (129)
Chapitre 04 : Ostéopathies fragilisantes (128)
Chapitre 05 : SDRC : algodystrophie (199)
Chapitre 06 : Polyarthrite rhumatoïde (196)
Chapitre 07 : Spondylarthrite (197)
Chapitre 08 : Arthropathie microcristalline (198)
Chapitre 09 : Infections ostéo-articulaires (156)
Chapitre 10 : Tumeurs des os (307)
Chapitre 11 : Rhumatologie transversale

Chapitre 01 — Douleur, épanchement articulaire, Arthrite (200)

Démarche diagnostique

Épanchement articulaire

Image (collège : épanchement articulaire du genou)

Arthrite

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Rhumatologie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Définition	Accumulation pathologique de liquide synovial dans la cavité articulaire -> traduit toujours une souffrance intra-articulaire qui peut être d'origines diverses
Physio.	Physiologiquement, il existe un faible film de liquide synovial qui n'est pas visible dans la plupart des cas (même avec des examens complémentaires sensibles : échographie, IRM)
Diagnostic positif	Diagnostic d'un épanchement articulaire est clinique : - Inspection : tuméfaction globale de l'articulation avec diminution des reliefs anatomiques - Palpation : confirme cliniquement l'épanchement (ex. choc patellaire au niveau du genou) - Hanche, Épaule à une moindre mesure : recherche impossible [X] (seule la limitation douloureuse sera analysée)
Diagnostic différentiel	- Ténosénovyte (épanchement situé dans les gaines synoviales tendineuses) : certains tendons sont entoure■s d'une gaine synoviale notamment lorsqu'ils passent au-dessus d'une zone a■ risque de friction (cheville, extenseurs des doigts), ici, la tume■faction se situe autour du tendon atteint et non dans l'articulation - Bursite ou Hygroma (inflammation d'une bourse séreuse de glissement) : amplitudes articulaires ne sont pas limite■es, avec une mobilisation passive conserve■e - Érysipèle : érythme superficiel mobile, sans limitation articulaire - TVP : oedème douloureux des parties molles
Imagerie	Échographie peut confirmer l'épanchement si doute ou articulation profonde (ex. hanche) (permet aussi de guider la ponction pour les articulations difficiles à ponctionner, ou si faible volume)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Rhumatologie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Nombre	- Monoarthrites : 1 articulation atteinte - Oligoarthrites : 2 ou 3 articulations - Polyarthrites : ≥ 4 articulations
Mode d'évolution	- Aiguë (< 3 mois) : fait suspecter une cause infectieuse ou cause microcristalline - Chronique (> 3 mois) : oriente vers un rhumatisme inflammatoire, plus rarement vers une infection à germes à croissance lente (tuberculose, maladie de Lyme) - Caracte■re re■current (ante■ce■dents d'e■pisodes similaires) pourra faire e■voquer une arthrite microcristalline ou un rhumatisme inflammatoire
Topographie	- Atteinte distale et symétrique -> polyarthrite rhumatoïde - Monoarthrite de l'articulation métatarso-phalangienne -> goutte - Oligoarthrite asymétrique des membres inférieurs -> spondyloarthrites périphériques
Fièvre	- Étiologie septique +++ - Étiologie microcristalline (plus rarement) - Étiologie rhumatismale (maladie de Still, polyarthrite rhumatoi■de)

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 17

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 17 • Rhumatologie (253 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège Français des Enseignants en Rhumatologie (COFER)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (253 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.